

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	重症肌無力的照護 Care of Myasthenia gravis				
編號	A31000-Q03-W-G04	制定者	R12 林碧嵐	公布日期	107 年 03 月 14 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.6 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解重症肌無力的原因、症狀、影響、常見治療、護理問題與措施以及衛教指導，使具備更適切之照護能力，以提供最佳護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

重症肌無力一種慢性、進行性的肌肉無力疾病。可發生於任何年齡層，但較常見於 20-30 歲，此期間女性的發病率約為男性 2-3 倍，50 歲以後，男女罹病率幾乎相等。在發病的第一年死亡率最高，發病後 4-7 年間為另一個危險期，過了這段期間後，病況多半穩定，危險性也隨著數個緩解期的出現而減低。

（二）原因

重症肌無力屬於自體免疫疾病，病人體內會產生對抗乙醯膽鹼接受器的抗體，造成神經和肌肉接合處的 Ach 的接收減少，以致神經衝動的傳導產生障礙。當大部份的傳導失敗，則將導致肌肉收縮無力現象。

（三）症狀

1. 重症肌無力是神經肌肉傳導的異常，症狀就是肌肉無力，通常肌無力呈現忽好忽壞的現象。腦神經所支配的肌肉以眼球外肌及顏面肌無力最常受影響，如：眼瞼下垂、複視、眼球活動麻痺、視力模糊、吞嚥困難及進食逐漸緩慢、說話聲音變小、口齒欠清，如果侵犯到吞嚥或呼吸肌肉則會造成吸入性肺炎及呼吸

主題名稱	重症肌無力的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G04	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	2/8

衰竭。肌無力大多侵犯近端的運動肌，會造成步伐不穩或抬臂、舉腿爬樓梯等困難，嚴重的病人才會顯現遠端的肌無力。

- 重症肌無力最大臨床特徵是早晨起床時精神體力最好，但隨著一天工作與時間過去，到下午或傍晚便逐漸出現眼皮下垂、複視與說話含糊不清，一副無精打采的樣子，但若有足夠休息或睡一覺醒來情況又會改善。
- 臨床分類依 Osserman 如下：小兒型、新生兒型、幼年型、大人型。大人型又分：第一類：侷限於眼球外肌。第二類（全身型）：又分為 A：無吞嚥、呼吸肌受損；B：侵犯吞嚥、呼吸肌。第三類：急性猛暴性的全身型。第四類：末期或第二類兩年以上。第五類：早期出現明顯肌肉萎縮臨床症狀。

（四）常見檢查

- 依據病史和臨床症狀來診斷：詢問何處肌肉產生無力現象，休息一段時間後症狀是否改善。
- 藥物測試：給予抗乙醯膽鹼酶藥物，抑制抗乙醯膽鹼被乙醯膽鹼酶水解，而增加乙醯膽鹼的量，可改善肌無力症狀。
 - tensilon 試驗：tensilon 為短效之乙醯膽鹼酶抑制劑，可增加肌肉，收縮力，大部分病人在靜脈注入 tensilon 後 30-60 秒，肌肉力量可明顯改善，持續約 4-5 分鐘。
 - neostigmine 試驗：neostigmine 為長效型的乙醯膽鹼酶抑制劑，以 neostigmine 1.5mg 加 atropine 0.6mg 皮下或肌肉注射 10-15 分鐘內，肌肉無力症狀會解除。
- 肌電圖：檢查神經肌肉間之傳導缺損，測試前 6-24 小時必須先停用抗乙醯膽鹼酶藥物。
- 抗乙醯膽接受器抗體：抗體呈現陽性反應時可確定診斷症。
- 實驗室檢查：甲狀腺功能測試、血液蛋白質電泳檢查，評估有無其他免疫方面之疾病。
- 電腦斷層攝影、磁振造影、胸部 X 光攝影可評估是否有胸腺瘤。

主題名稱	重症肌無力的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G04	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	3/8

（五）常見治療

1. 藥物：

(1)乙醯膽鹼製劑：乙醯膽鹼酶抑制劑是第一線藥物，俗稱大力丸，刺激乙醯膽鹼接受器，使神經末梢的乙醯膽鹼濃度上升，增加對接受器的作用，促進神經肌肉間的傳導，增加肌肉的力量。服藥後約 20~30 分鐘開始作用，一天服用三次。副作用：噁心、拉肚子、流口水、心跳減慢、或暈厥症發生。當乙醯膽鹼酶抑制劑療效不佳，可以考慮使用免疫抑制劑。

(2)類固醇：抑制淋巴組織的免疫機能，使症狀減輕，不論服用哪種藥物皆需在醫師處方下使用，且不可任意停止或增減藥量。

2. 血漿置換術：目的為除去血漿內之自體抗體。如果重症肌無力症狀太嚴重，需要使用呼吸器的時候，就可以考慮使用血漿置換方式治療，可以快速移除血液中乙醯膽鹼受體的抗體，大約 2~3 天症狀就改善，但是緩解時間只能維持幾個星期，此處置對於穩定病程之病人無效，而且大量使用血漿有潛在感染問題。
3. 胸腺切除：重症肌無力病人約有 10%合併胸腺腫瘤，70%有良性的胸腺增生，如果有胸腺增生或是胸腺瘤，可以接受胸腺切除手術，症狀緩解的效果會在手術後一段時間才看的到，甚至需要好幾年的時間。若與服用藥物的患者比較，接受手術的患者症狀減輕甚至恢復正常的比例大約是在 1.5 倍至 2 倍。此治療方式適用影像檢查確診胸腺瘤且對藥物治療反應不佳者，施行胸腺切除術，可降低藥物使用量及改善症狀。

（六）護理問題

1. 無法有效呼吸/肌肉無力
2. 活動耐力不足/運動肌肉神經傳導受損
3. 尋求(特定的)健康協助/缺乏正確的資訊

（七）護理措施

1. 無法有效呼吸/呼吸肌無力

(1)定期監測紀錄呼吸型態及生命徵象。

主題名稱	重症肌無力的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G04	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	4/8

- (2)協助將病人痰液及口水抽出，維持呼吸道通暢。
- (3)教導家屬照顧技巧，例如：姿位引流、胸部叩擊及拍背等技巧。
- (4)預防病人發生呼吸道感染，如:避免和呼吸道感染者接觸。
- (5)準備抽痰設備在旁，經評估無法咳出痰液或口水時，給予抽痰避免呼吸道阻塞。
- (6)教導及協助病人最佳換氣和舒適姿勢，包括：抬高床頭 60 度、採半坐臥或左右側臥姿勢。
- (7)教導評估呼吸功能的方法（聽診、肺功能測試等），及不明物吸入時的緊急處理法。

2. 活動耐力不足/運動肌肉神經傳導受損

- (1)協助病人及家屬確認會減少病人活動耐力不足的因素，例如：睡眠不足、藥物、治療或環境因素。
- (2)提供病人集中式護理，使病人有充分的休息。
- (3)病人活動前、中、後期監測生理狀態，確定有無心臟血管、呼吸系統、皮膚等各方面的改變。
- (4)協助病人日常活動，評估病人活動耐力不足的程度和提供休息的時間。
- (5)教導評估肌肉力量及減輕肌肉疲勞、無力現象的方法，例如：適當分配一天的活動，活動之間能有適當休息。
- (6)協助建立較為實際、能達成的目標，以減少挫折感。
- (7)建議穿著舒適穩定性高的鞋子，預防意外跌倒。
- (8)鼓勵家屬多陪伴及支持病人。
- (9)當病人自我照顧時，給予鼓勵和正向強化，強調病人能做的來代替強調病人不能做的。
- (10) 鼓勵病人和重要親友參加，計畫病人出院後，雙方都能接受的日常活動休息時間表。

3. 尋求(特定的)健康協助/缺乏正確資訊

主題名稱	重症肌無力的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G04	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	5/8

- (1)利用口述及書面資料提供病人疾病相關訊息，如：疾病之病因、治療及照顧。
- (2)隨時提供病人正確訊息，以矯正錯誤觀念，如：重症肌無力非絕症無藥可治，只要按時依醫囑服藥，維持正常、規律生活等，使症狀改善。
- (3)協助病人將疾病知識運用於生活中，如：於飯前 30-45 分鐘前服用抗乙酰膽鹼藥物，以防吞嚥困難造成吸入性肺炎等。
- (4)要求病人家屬或重要親友參加學習過程，因家屬能加強及澄清病人所學新知。
- (5)和病人及家屬共同討論及檢視所能回想的知識，評估了解程度。
- (6)提供病人及家屬社會資源，如中華民國肌無力俱樂部，提供俱樂部簡介、認識重症肌無力症、檢驗和診斷、病人日常照護、緊急照護處理以及醫學資源等內容，以協助病人對疾病的認識。
- (7)介紹成功案例，協助疾病分享及交流。
- (8)外出時需佩帶記有疾病資料之識別卡，應註記診斷名稱及主治醫師姓名、電話，以備緊急需要時提供急救訊息。

(八) 衛教指導

1. 盡量避免呼吸道感染；若有無力增加、輕微發燒、寒顫、咳嗽現象請立即就醫，以免病情加重。
2. 按時門診追蹤治療及正確服用藥物。
3. 避免抽煙、喝酒。
4. 家具的擺設及坐浴用品放置，以簡單及方便容易取得為原則，以節省體力，及減少生活行動上的不便。
5. 生病就醫時，須告知醫師自己的病史，避免使用不適當藥物，尤其是鎮靜劑及麻醉劑等。
6. 隨身攜帶識別證，註明疾病、姓名、住址、連絡人電話。
7. 保持規律生活，避免過度勞累，多休息，並要有充足的睡眠。
8. 保持情緒平衡，避免過度興奮、緊張、生氣、焦慮。

主題名稱	重症肌無力的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G04	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	6/8

9. 懷孕可能會加重肌肉無力症狀，必須密切與醫師聯繫並討論。

(九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 潘怡旻(2020)・一位重症肌無力個案面臨初次重症肌無力危象之護理經驗・長庚護理，31(3)，395－403。
- (二) 羅玉岱、陳乃菁、楊宜青(2020)・周全性老年評估個案報告：一位以衰弱為臨床表現之老年發病重症肌無力的婦女・台灣老年醫學暨老年學會雜誌，15(3)，199-213。
- (三) Narayanaswami, P., Sanders, D. B., Wolfe, G., Benatar, M., Cea, G., Evoli, A., ... & Verschuuren, J. (2021). International consensus guidance for management of myasthenia gravis: 2020 update. *Neurology*, 96(3), 114-122.

七、附件

(略)

主題名稱	重症肌無力的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G04	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
107.03.14	1.0	新制定。	107 年 03 月 14 日護理長會議通過。
107.09.12	1.1	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 3 新增參考資料說明。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.03.06	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.04.11	1.2	第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 04 月 11 日照護標準組會議通過； 108 年 05 月 15 日護理長會議通過； 108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	1.3	第一項說明文字修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過； 110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	1.4	1. 第三項第六目、第七目護理問題及護理措施內容部份修辭潤飾。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過； 111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	1.5	1. 第三項第六目、第七目護理問題及護理措施內容部份修辭潤飾。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過； 112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.10.15	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	重症肌無力的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G04	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	8/8

115.01.06	1.6	第六項參考資料文獻部份內容更新。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。
-----------	-----	------------------	--